

Información Paciente

Nombre : Oscar Guillermo Opazo Rodríguez **Rut** : 6.871.098-7 **N° Archivo** : 0312802
Edad : 71a 8m 3d **Fecha Nacto**: 13/06/1953 **Sexo** : Masculino
Dirección : Gabriela Oriente 02336 Villa Las Nieves **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 986346996

N° Epicrisis
430949

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim **Fecha Ingreso** : 05/02/2025 22:14 **Días Estadía**: 11
Unidad de Egreso : Utim (5to Piso Mater) **Fecha Egreso** : 16/02/2025 14:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Melena y Hematemesis

Comorbilidades

Hipertensión Arterial; Acv No Secuelado; Diabetes Mellitus;

Procedimientos

15/02/2025 - Manejo De Traqueostomía
07/02/2025 - Cambio De Canula Traqueostomía

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Última Hospitalización: 28/10/24 - 25/01/25. Se mantenía en HSJM por lo que técnicamente ha estado hospitalizado desde entonces.

Ingreso UTIM HSR: 06/02/2025

ANTECEDENTES

- MORBIDOS: HTA, DM2 NIR, ACV isquémico frontal derecho + hematoma intraparenquimatoso occipital izquierdo subagudo no secuelado (2018), HPB en estudio, usuario de CUP una semana antes de ingreso del 28/10/24. Carcinoma basocelular en canto interno ojo izq
- QUIRÚRGICOS: Apendicectomía, extirpación de carcinoma basocelular en canto interno ojo izq (2022).
- FÁRMACOS: Acido acetilsalicílico 100 mg al día, Atorvastatina 40 mg al día, Losartan 50 mg cada 12 horas, Metformina 850 mg cada 8 horas, Duloxetina 30 mg al día, Omeprazol 20 mg cada 24 hrs, PEG 17 gr cada 8 hrs, Paracetamol 1gr cada 8hrs, Trazodona 50 mg en la noche, Eszopiclona 2 mg noche, Morfina 3 mg EV cada 6 hrs + 3 mg EV SOS, Metamizol 1 gr EV SOS si dolor,
- ALERGIAS: Niega
- HáBITOS: Tabaco activo, hasta 2 cajetillas diarias, OH Suspendido, Drogas (-)
- INMUNIZACIONES: SARS CoV2 5 dosis / Influenza 2024 (+) / Pneumococo (-)

Resumen de la hospitalización previo al ingreso a UTIM HSR el 06/02/25

Motivo de ingreso: melena

CSV: PA 92/68 FC 97 sat 96% con 3 lt. Lab: crea 9 BUN 160 Leucocitos 35.130 PCR 384 SO inflamatorio

AngioTAC: múltiples áreas de nefritis bilateral + HUN izquierda. En urgencias evoluciona con hematemesis 500 ml aprox, con hipotensión por lo que se intubó el 28/10.

EDA: gran coágulo adherido en tercio distal del esófago, obs úlcera esofágica IIb.

Se trasladó a UCI (29/10 al 24/11) / UTIM (24 al 25/11) / UCI (25/11 al 07/12) / Geriatria (07/12 al 25/01), evolución por problemas:

- HEMODINÁMICO: Llegó a requerir 3 DVA: NAD, adrenalina y vasopresina. 01/11 suspende vasopresina, 02/11 suspende adrenalina, suspende NAD a mediados de noviembre, recibió corticoides en dosis de estrés. En relación a re-intubación del 25/11 requirió NAD y AD que se suspendieron el 28/11.

Fecha Epicrisis : 16/02/2025 12:29

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 16-02-2025 12:29:37

Página 2 de 4

- RESPIRATORIO: IOT al ingreso, prolongada por lento despertar e interurrencias infecciosas. En relación a NAVM requirió BNM entre 05 y 08/11. Suspende sedación el 16/11. Se extuba 21/11 con salida a CNAF 50/40. 24/11 se traslada a UTIM donde a las horas el 25/11 presenta cuadro de compromiso de conciencia con pérdida de protección de vía aérea y desaturación hasta 75% por lo que se re-intubó. Se realizó TQT percutánea el 27/11, logró destete VMI el 01/12. El 14/12 presenta desaturación severa 50% obs laringo-espasmo. Decidieron no conexión a VMNI y ante no respuesta a MAF iniciaron BIC morfina. Logró repuntar.

- RENAL: requirió HDFVVC 30/10, 04/11 TRR modalidad SLED y HD entre 09 y 18 o 19/11. Posteriormente no fue conflicto

- INFECCIOSO: múltiples hits, los más relevantes:

- PNA al ingreso tratada con imipenem
- 05/11 CAET (+) PSAE MS + ACBA MR + KPN no BLEE: inició manejo con colistin NBZ y se mantuvo imipenem, con antibiograma se ajustó terapia a Tigeciclina y Ceftazidima (hizo trombocitopenia severa a Tigeciclina).
- 25/11 portación KPN NDM + Citrobacter NDM
- 25/11 CAET (+) KPN + Citrobacter freundii + PSAE, inicialmente se cubrió empírico con vancomicina, imipenem y ceftazidima
- 03/12 CAET (+) ACBA XDR + PSAE MDR + KPN NDM: se inició tigeciclina doble dosis + ceftolozano/tazobactam
- 12/12 TAC con absceso renal izquierdo, por UC previos con C. albicans se cubre con fluconazol a sugerencia de infectología. 17/12 se realiza drenaje por Radiología intervencional con cultivo positivo para Cándida albicans por lo que se mantuvo con fluconazol hasta el 16/01 (resolución del absceso, retiro drenaje)- ECOTT 14/01 con regular ventana, sin vegetaciones.
- 14/12 CAET (+) ACBA + KPN BLEE + UC (+) KPN BLEE, se trató con ceftazidima/avibactam + aztreonam por 7 días.
- 31/12 COVID19 (+)

- GASTRO: Ingresó por hemorragia digestiva alta, del estudio:

- 1ra EDA 28/10: gran coágulo adherido en tercio distal del esófago, obs úlcera esofágica IIb.
- 2da EDA 01/11: úlcera esofágica distal sin sangrado activo
- 3ra EDA 05/11: sin sangrado activo.
- 05/11 reinicia régimen progresivo

- META NUTRICIONAL: Fresubin HP 65ml/hr

- UROLÓGICO: múltiples intentos de retiro de CUP frustrados.

- REHABILITACIÓN:

- TQT/DEGLUCIÓN: se describe hipersecretor, se mantuvo con atropina o escopolamina. Comienza entrenamiento con VF 10/12 y se detiene el 14/12 por interurrencia, retoma rehab el 19/12, con tolerancia de 20 ¿ 30 min máximo. 15/01 se realizó único BDT que fue positivo pero secundario a evento irritativo y retiro VF.

Evaluado por ORL 02/01 describe: falta de reflejo de cierre de glotis al deglutir. Control con NFC en 4 semanas. Con esto planificaron GTT que se realizó el 20/01

Por disfunción se cambió TQT 8.0 el 17/01

- MOTOR: TSBC con mínima asistencia, bípedo con andador, marcha con 2 operadores 5 vueltas por sala. Describen fatiga rápida.

Barthel de egreso: 25.

HISTORIA CLÍNICA ACTUAL

Paciente con extensa hospitalización en relación a HDA, que cursó con múltiples interurrencias infecciosas, crítico crónico usuario de TQT y GTT, trasladado a HSJM para rehabilitación. Es derivado desde dicho centro por cuadro de 1 día de evolución caracterizado por hematemesis en 4 ocasiones y melena en 3 ocasiones, asociado a hipotensión. Laboratorio inicial demostró Hb 5.9, inició terapia con NAD hasta 0.15 por VVP siendo trasladado a CASR para evaluación y manejo. Ingresó a REA en malas condiciones generales FC 99, PA 76/38, PAM 47, T° 36.7, Sat 99% MAF a 6 Lts. Al examen físico de ingreso se describió consciente; TQT con restos hemáticos, llene capilar de hasta 4 segundos, frío a distal con Mottling Score 1, Abdomen doloroso a la palpación difuso. No se describe tacto rectal. Laboratorio de ingreso objetivó Hb en 4.9, se transfundió 4 uGR. Inició manejo con IBP en altas dosis y se solicitó EDA que requirió sedación y manejo con O2 por TQT. De EDA (06/02) se informó presencia de: esofagitis péptica grado D de los Angeles y úlcera esofágica con vaso sangrante Grado IB sobre la que se hizo manejo con inyectoterapia y Clip. Posteriormente finaliza procedimiento de manera estable, logrando suspensión de NAD en la madrugada de 06/02, con Hb de control en 11. En este contexto de traslado a UTIM, donde evolucionó:

HEMODINAMIA: Estable, NAD suspendida a su ingreso UTIM, Hb estable en 8.4, sin exteriorización de sangrado. Estudio de anemia con algo de ferropenia (Fe 38 TIBC 186 sat 20%), recibe carga de 400 mg.

Fecha Epicrisis : 16/02/2025 12:29

Página 2 de 4

RESPIRATORIO: Usuario de TQT crónico, por tapones y PSG disfuncional 07/02 se cambió TQT a 8.0 con EC y PSG. Tras completar 24 horas de oclusión bien tolerada, se decanuló el 15/02 sin incidentes.

DIGESTIVO: HDA por úlcera esofágica Forrest Ib. Se realizó manejo con inyectoterapia y Clip 06/02. Se mantuvo IBP en dosis altas por 72 horas y régimen cero por 24 horas. Tras inicio de alimentación presentó melena que impresiona residual. Posteriormente sin conflicto, progresó en régimen comentado en apartado rehabilitación.

NEFRO: AKI KDIGO II de causa prerrenal por cuadro de sangrado digestiv. De forma paralela evolucionó con RAO por lo que se re-instaló CUP, que también pudo tener rol en AKI. Posteriormente tuvo leve alza en creatinina, que impresionó por pre-renalidad, por lo que se volemezó con cristaloides con buena respuesta.

UROLOGICO: se rescató RNM pelvis de julio 2024 con lesión prostática sospechosa de malignidad PIRADS5, se envió IC a urología para evaluar conducta a seguir, quienes indicaron tomar APE (11.85) y control post alta a la semana en poli urología con Dr. Del Valle, CDT pasillo 9, día lunes a las 10:30 horas sobrecupo autorizado. Dado lo anterior, mantener con CUP al alta.

REHABILITACIÓN

TQT: cambio TQT 8.0 con EC y PSG el 07/02. 10/02 PIM -39.6cmH₂O PEM 54.7cmH₂O. Progresó de muy buena manera en rehabilitación, toleró 24 horas de oclusión por lo que se decanuló el 15/02.

DEGLUCIÓN: en seguimiento por FNA. BDT saliva el 10/02 negativo, 12/02 se autorizó régimen complementariobien tolerado por lo que 14/02 se realizó retiro de GTT sin incidentes (con ayuda de centro endoscópico)

MOTOR: logrando SBC c on mínima asistencia, bipedestar con mínima asistencia donde logra cargar pesos y mantener posición y ME con dificultar en elevacion del paso, se pasa a sillón. Se realiza GES de ayudas técnicas.

DIAGNÓSTICOS

- Shock hemorrágico resuelto
 - Úlcera esofágica Forrest IB (clip + inyectoterapia 06/02)
 - Esofagitis péptica grado D de los Ángeles
- AKI KDIGO I prerrenal en recuperación
- Lesión prostática sospechosa PIRADS 5, obs Cáncer de próstata
- Critico crónico
 - Usuario de GTT 20/01/25, retirada 14/02
 - Usuario TQT 27/11/24, decanulado hoy 15/02

Antecedentes

Epicrisis realizada por Dra. Fabiola Garrido

Epicrisis entregada por Dra. Karol Villalobos

Diagnóstico de Egreso

Úlcera Péptica, De Sitio No Especificado, Con Hemorragia -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente estable, en buenas condiciones generales, hemodinamia estable. Cumple 24 horas desde decanulación y 48 horas desde retiro de GTT por lo que está en condiciones de continuar rehabilitación en domicilio.

Se solicita UHD para:

- Kinesiología motora para continuar proceso de rehabilitación
- Fonoaudiología para progresar en régimen y terapia de voz
- Enfermería para curación de ostomas de TQT y GTT.

Plan Post Alta

INDICACIONES

- Reposo relativo, retomar paulatinamente y a tolerancia actividades de la vida diaria, progresar con kinesiología motora por UHD
- Curaciones de ostomas de TQT y GTT por enfermería de UHD
- Régimen para diabético, bajo en sal. Blando sin granos + líquidos claros con bombilla + pan de molde, progresar en consistencias según fonoaudiología de UHD

Fecha Epicrisis : 16/02/2025 12:29

Fecha Última Actualización: 16-02-2025 12:29:37

Página 4 de 4

- Mantener catéter urinario.

MEDICAMENTOS:

- Esomeprazol 40 mg al día vía oral a permanencia
- Sulfato ferroso 200 mg al día vía oral por 3 meses
- Atorvastatina 20 mg en la noche vía oral
- Tamsulosina 0.4 mg al día vía oral
- Metformina 850 mg 3 veces al día, antes o con las comidas.
- Duloxetina 30 mg al día vía oral
- Eszopiclona 2 mg en la noche vía oral
- Paracetamol 1 gramo cada 8 horas vía oral hasta término de curaciones de ostomas, luego 1 gr en caso de dolor fiebre, máximo 3 veces al día

CONTRLES:

- Control en CDT Urología (pasillo 9) Lunes 17/02 a las 10:30 hrs con Dr. Del Valle, sobrecupo autorizado.
- Control en su CESFAM para seguimiento de Hipertensión y Diabetes. Además, administrar vitamina B12 10.000 UI mensual IM (usuario de metformina)
- En caso de no cierre de ostoma de TQT o GTT en 3 meses, debe ser derivado desde su CESFAM a ORL o gastroenterología, respectivamente.
- Acudir a CDT Medicina física y rehabilitación para obtención de ayudas técnicas.

En caso de nuevo sangrado gastrointestinal, fiebre, dificultad respiratoria o en caso que estime necesario, acudir a servicio de urgencias más cercano.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Levantar Diariamente

Régimen Alimentario : Blando Sin Granos Más Líquidos Claros

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Karol Joyce Villalobos Gallardo
Médico Tratante (Staff)